

卡马西平的药物相互作用

尹宗莹

摘要：对卡马西平与多种药物之间的相互作用及不良反应进行综述。

关键词：卡马西平； 相互作用

中图分类号： R749.053 **文献标识码：** A **文章编号：** 1005-3220(2008)03-0208-02

我们对卡马西平与其他药物的相互作用综述如下。

1 与抗精神病药物的相互作用

1.1 氯丙嗪 有人对氯丙嗪或氯氮平与卡马西平合用治疗精神运动性兴奋进行对照研究,结果发现合用卡马西平后睡眠时间明显延长,且兴奋症状得到明显控制,近期疗效优于单用组。但卡马西平系细胞色素 (CYP)P450 诱导剂,二者合用会降低氯丙嗪的血药浓度,停用后可恢复正常。

1.2 氯氮平 不宜合用。因为氯氮平可影响造血系统,抑制骨髓的造血功能,而卡马西平同样对造血系统有毒性,两药联用势必会增加造血系统的毒性作用,增加粒细胞缺乏的危险性。Raitasuo报道 2例氯氮平与卡马西平长期联用后,停用卡马西平可使氯氮平血药浓度升高。没有关于不良反应的描述,其原因是卡马西平有较强的酶诱导作用。联用会降低氯氮平的血药浓度。联用前要仔细权衡用药的安全性和危险性,联用后,监测白细胞和血药浓度至关重要^[1~4]。当停用卡马西平时,注意监测氯氮平的血药浓度。

1.3 甲硫哒嗪 联用可能造成卡马西平中毒。因为二者合用后,卡马西平的血药浓度仅 3.7 mg/L 即可出现意识障碍、谵妄等中毒症状,停药 12 h后恢复正常^[5]。故合用时需谨慎。

1.4 利培酮 合用可增加利培酮的清除率,降低利培酮的血药浓度,导致疾病复发,故合用时需特别注意^[6]。

1.5 阿立哌唑 卡马西平 200 mg/d与阿立哌唑 30 mg/d合用时,阿立哌唑和脱氢阿立哌唑的峰值浓度和 AUC 值比阿立哌唑单用时减少 70%,增加了阿立哌唑的清除率。如需合用时,阿立哌唑剂量应该加倍,但是其临床意义有待评估^[7]。

1.6 奥氮平 卡马西平有可能通过对 CYP1A2 的诱导,刺激奥氮平的生物转化,因而降低奥氮平的血药浓度。在研究中二者合用可导致奥氮平的清除率增加 46%;在临床治疗中,卡马西平和标准剂量的奥氮平合用后,奥氮平的血药浓度低于奥氮平单一治疗的 36%~71%^[8]。

1.7 奎硫平和齐拉西酮 卡马西平能加速奎硫平和齐拉西酮的代谢,可能是由于 CYP3A4 的诱导作用所致。卡马西平 200 mg 每日 3 次,可使奎硫平的最大血药浓度减少 80%,清除率增加约 7.5 倍。有与齐拉西酮合用后,齐拉西酮的最大血药浓度平均减少 27%^[8]。

2 与心境稳定剂的相互作用

2.1 锂盐 张菊英等^[9]用锂盐合并卡马西平治疗快速循环型心境障碍,取得了比较满意的疗效。笔者认为,二者合用

治疗躁狂起效快,有加强协同作用,尤其是对难治性、双相情感型、快速循环型心境障碍可作为首选,而二者可取长补短,预防卡马西平导致白细胞减少的不良反应。不过,有报道卡马西平与锂盐联用可发生神经中毒症状,如意识障碍、眼球震颤、复视等。有中枢神经系统合并症应避免使用^[5]。

2.2 丙戊酸钠 对于一些难治性心境障碍以及单一治疗不能终止发作的快速循环型心境障碍,卡马西平联合丙戊酸钠是推荐的联合治疗方案^[10]。卡马西平是一种较强的肝药酶诱导剂,可加强丙戊酸钠在肝脏的代谢,其代谢生成的肝毒性物质 4 烯 丙戊酸增加 2 倍,使丙戊酸钠血药浓度降低;丙戊酸钠可增加卡马西平活性代谢产物 卡马西平环氧化物,延长其半衰期,提高其浓度,卡马西平联合丙戊酸钠倾向引起较宽的血药浓度波动,服药数周才趋于稳态^[4]。当二者联用时,必须经常监测血药浓度,以减少危险。

3 与抗癫痫药的相互作用

3.1 巴比妥类 苯巴比妥、去氧苯巴比妥都是酶诱导剂,均可使卡马西平血药浓度下降^[11],是否需要因此增加后者的剂量,要根据临床情况而定。

3.2 乙琥胺 与卡马西平合用时,二者的代谢加快,致血药浓度降低,容易导致疾病发作,最好不要合用。

3.3 拉莫三嗪 卡马西平会增强拉莫三嗪的代谢,而需加大剂量。卡马西平与拉莫三嗪合用后有中枢神经系统反应的报道,包括头痛、恶心、视力模糊、头晕、复视和共济失调。这些反应在减少卡马西平的剂量后通常都会消失。

4 与抗抑郁药的相互作用

4.1 三环类抗抑郁药 有报道卡马西平可降低阿米替林和去甲替林血药浓度达 50%,其机制可能是卡马西平的酶诱导作用,加快了肝脏代谢,使药物浓度下降。

4.2 氟西汀 卡马西平与氟西汀联用时,氟西汀可以竞争性抑制肝脏的代谢过程,而与卡马西平产生协同交互作用,导致血药浓度增加和药物不良反应明显化^[12 13]。

4.3 帕罗西汀 已有报道帕罗西汀与卡马西平联用时,后者血浆浓度并无增高,提示帕罗西汀对 CYP450 3A4 不产生抑制作用。^[14]已达到卡马西平血中稳态的癫痫患者合用帕罗西汀时,未发现其血药浓度和血浆蛋白结合率有明显改变,对卡马西平的疗效无明显影响^[15]。

5 与抗生素的相互作用

5.1 抗结核药 异烟肼可抑制卡马西平的代谢,使其血药浓度增高,而引起毒性反应,卡马西平可诱导异烟肼的微粒体代谢,形成具有肝毒性的中间代谢物增加。有资料报道 13 例卡马西平联合异烟肼治疗的患者,有 10 例出现不良反应,如定向障碍、疲倦、攻击、昏睡等,3 例做了卡马西平血药

浓度监测,虽然剂量减半,但是血药浓度依然偏高。对氨基水杨酸钠在肝脏代谢,经乙酰化而失活,是肝药酶抑制剂,可使卡马西平血药浓度升高^[16]。

5.2 红霉素 卡马西平与红霉素合用时,卡马西平的清除率降低,导致血药浓度增高^[17]。此外,卡马西平几乎完全进入肝内微粒体系代谢,红霉素可与卡马西平竞争 CYP450酶结合,卡马西平的氧化代谢需要 CYP450酶,从而干扰卡马西平的代谢,诱发卡马西平中毒^[18]。

5.3 氯霉素和磺胺类 氯霉素、磺胺类药物均有不同程度的肝药酶抑制作用,可使卡马西平的血药浓度升高,当合用时应减少卡马西平的剂量。

6 与抗凝剂的相互作用

卡马西平可加强华法林的代谢,降低其凝血作用,合用时需要增加后者的剂量,才能保证其凝血功能^[11]。同时,卡马西平也可加速双香豆素、华法林的代谢,而降低其血药浓度,降低凝血作用。

7 与其它药物的相互作用

卡马西平与避孕药合用,会加速避孕药的代谢而使避孕失效。与皮质激素合用,可降低地塞米松、泼尼松等血药浓度。与茶碱合用,可降低茶碱血药浓度,合用时要增加茶碱的剂量;而停用卡马西平时,要及时调整茶碱的剂量,最好监测血药浓度。卡马西平与美沙酮合用,可降低美沙酮的血药浓度而出现戒断症状。上述作用与卡马西平具有酶诱导作用,加速药物代谢有关。

卡马西平与西米替丁合用,由于西米替丁与 CYP450酶有较强的亲和力^[3],抑制 CYP450酶的活性,从而会使卡马西平的血药浓度增高,产生不良反应,最好避免使用西米替丁,可用雷尼替丁或法莫替丁。

参考文献:

[1] 李明亮,庞建立.氯丙嗪或 和氯氮平加用卡马西平对精神运动性兴奋状态患者的睡眠及疗效的影响 [J].中原精神医学学刊,1997,3: 218-219.

[2] 钱敏才.传统与新型抗精神病药所致非锥外副作用 [J].国外医学精神病学分册,1998,25: 78-80.

[3] 候静.影响氯氮平药代动力学的物质 [J].国外医学精神病学分册,1998,25: 179-181.

[4] 沈锦相.临床不合理用药 15例分析 [J].云南精神医学杂志,1994,2: 5.

[5] 彭斌.心境稳定剂的联合应用 [J].国外医学精神病学分册,1998,25: 167.

[6] 陈福新,秦红群,董维琼.利培酮的药物相互作用 [J].临床精神医学杂志,2005,15: 373-374.

[7] 左笑丛,李焕德.新抗精神病药物阿立哌唑的药代动力学 [J].中国临床药理学杂志,2005,21: 470-474.

[8] 李强译.新型抗精神病药的药物代谢相互作用:比较综述 [J].精神相关疾病论坛,2007,1: 36-52.

[9] 张菊英,周宪钦.卡马西平合并锂盐治疗快速循环型情感障碍 13例分析 [J].中原精神医学学刊,2001,7: 164-165.

[10] 喻东山,李广路.卡马西平的精神科使用近况 [J].国外医学精神病学分册,2005,32: 242-245.

[11] 王祖诤,裴印权,金有豫.临床精神药理学 [M].北京:北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社,1990: 188-189.

[12] 王继军,王祖承.氟西汀(百忧解)的临床应用 [J].国外医学精神病学分册,1995,22: 193-201.

[13] 袁浩龙.新型抗抑郁药与细胞色素 P450系统 [J].国外医学精神病学分册,1997,24: 39-43.

[14] 欧红霞,喻东山,张心保.细胞色素 P450酶系统和精神药物 [J].临床精神医学杂志,1998,8: 291-294.

[15] 叶显撑,王洪泉.选择性 5羟色胺再摄取抑制剂与药物的相互作用 [J].中国医院药学杂志,1998,18: 416-417.

[16] 沈渔村.精神病学 [M].3版.北京:人民卫生出版社,1997: 986-988.

[17] Carmanco E. Camazepin toxicity induced by concurrent ery thro mycin therapy [J]. Arch Neurol 1985, 42: 187.

[18] 刘自强.卡马西平的毒副作用 [J].国外医学神经病学(神经外科)分册,1988,15: 16.

(收稿日期: 2007-08-17)

• 病例报告 •

奋乃静与帕罗西汀合用致迟发性运动障碍 1例

丁晓烨

关键词： 奋乃静； 帕罗西汀； 迟发性运动障碍
中图分类号： R749.053 文献标识码： B 文章编号： 1005-3220(2008)03-0209-01

1 病例

患者女,66岁。因失眠、心烦来我院就诊。既往有脑梗死病史。院外服用帕罗西汀(商品名:赛乐特)20 mg/d 劳拉西洋 0.5 mg 每晚 1次。患者口唇、舌重复的、不自主运动,睡眠时消失。追问病史方知每晚自服奋乃静 2 mg 已 10 d,即停服奋乃静,1周后复诊,不自主运动消失。

2 讨论

本例患者为老年人,同时合并脑器质性疾病,是引起迟发性运动障碍(TD)的高危人群。奋乃静通过细胞色素 P4502D6酶代谢,而帕罗西汀是此酶的抑制剂,从而使奋乃静的血药浓度增加,所以此患者服用奋乃静 2 mg/d即出现 TD。提醒临床医师,在抗精神病药和抗抑郁药合用时,一定要注意药物间的相互作用。

(收稿日期: 2008-01-27)